

БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар департаментинин
директору
Бекбоев К.Т.

« 12 » ноябрь 2025-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ПАРДИФЕН

Соодадагы аталышы

Пардифен.

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Жок.

Дарынын түрү

Таблеткалар

Курамы

Ар бир таблеткада төмөнкүлөр камтылат:

Активдүү заттар:

Парацетамол ВР 500 мг

Диклофенак натрий ВР 50 мг

Көмөкчү заттар:

микрочисталлидуу целлюлоза, крахмал (жүгөрү крахмалы), повидон (Р.В.Р.К 30), желатин, метилгидроксibenзоат (метилпарабен), пропилигидроксibenзоат (пропилпарабен), целлюлоза ацетатфталаты (Cellacefate), ацетон, Sunset Yellow Lake боёгучу, тазартылган суу, магний стеараты, тазартылган тальк, натрий крахмалгликоляты, суусуз коллоиддүү кремний диоксиди.

Сүрөттөмөсү

Тешиктери бар блистерде сүйрү, эки жагы томпок, кызгыл сары түстөгү капталбаган таблеткалар.

Фармадарылык тобу: Стероиддик эмес сезгенүүгө каршы жана ревматизмге каршы препараттар. Укусус кислотасынан алынгандар жана алардын тектеш кошулмалары. Диклофенак башка препараттар менен айкалышта.

АТХ коду: M01AB55.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Пардифен – айкын сезгенүүгө каршы, ооруну басуучу жана дене ысыгын төмөндүүчү таасир көрсөткөн айкалышкан препарат. Препараттын фармакологиялык активдүүлүгү препараттын курамына кирген диклофенак жана парацетамолдун өзгөчөлүктөрү менен шартталган. *Диклофенак* – фенилуксус кислотасынан алынган ооруну басуучу жана дене ысыгын төмөндөтүүчү, антиагреганттык таасир көрсөтөт. Циклооксигеназа (ЦОГ) 1 жана 2ни басаңдатуу менен арахидон кислотасынын зат алмашуусун бузат, простагландиндердин санын сезгенүү очогунда азайткандай эле, дени сак ткандарда да азайтат, сезгенүүнүн экссудативдик жана пролиферативдик фазасын басат.

Парацетамол – көбүнчө борбордук нерв системасында ЦОГду тандабай бөгөйт, туздуу-суулуу алмашууга жана ашказан-ичеги жолунун (АИЖ) былжырлуу челине бир аз таасир берет. Пероксидазанын сезгенген ткандарында парацетамолдун ЦОГ 1 жана 2ге таасирин нейтралдаштырат, ал сезгенүүгө каршы таасирдин дээрлик толук жоктугун түшүндүрөт.

Фармакокинетикасы

Пардифен препаратын ичкенден кийин диклофенак жана парацетамол тез жана толук сиңет. Тамак препараттын сиңүүсүнө таасир бербейт.

Кан плазмасындагы активдүү заттардын концентрациясы препараттын дозасынан сызыктуу көз карандылыкка ээ, эң жогорку деңгээлдерге препаратты кабыл алгандан 60–90 минута өткөндөн кийин жетет.

Диклофенактын кан сары суусунун белоктору (көбүнчө бөлүгү альбумин менен) менен байланышы 99,7% жетет. Бөлүштүрүүнүн шарттуу көлөмү 0,12–0,17 л/кг түзөт. Диклофенак муун суюктугуна кирет, ал жерде анын эң жогорку концентрациясына кан плазмасына караганда 2-4 саатка кеч жетет. Муун суюктугунан жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили 3-6 саатты түзөт.

Диклофенактын зат алмашуусу бир нече фенолдук метаболиттердин пайда болушуна алып келүүчү өзгөрбөгөн молекуланы глюкуронизациялоо жолу жана метоксилирлөө менен жүрөт, алардын биологиялык активдүүлүгү баштапкы заттыкынан кыйла төмөн.

Диклофенактын жалпы системалык плазмалык клиренси болжолдуу 300 мл/мин түзөт. Акыркы жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили – 1-2 саат. Куюлган дозанын 60% өзгөрбөгөн диклофенактын глюкурондук конъюгаттары түрүндө заара менен, калган бөлүгү өт жана заң менен бөлүнүп чыгат.

Парацетамол боордо зат алмашат жана негизинен заара менен бөлүнүп чыгат. Пардифен препаратын кайталап колдонгондон кийин активдүү заттардын фармакокинетикалык көрсөткүчтөрү өзгөрбөйт. Таблеткаларды кабыл алуулардын ортосундагы сунушталган аралыкты сактоодо препараттын топтолуусу байкалган эмес.

Колдонууга көрсөтмө

- Таяныч-кыймыл аппаратынын сезген оорулары (ревматоиддик артрит, псориаздык, ювенилдик жана өнөкөт артрит, омуртка муундарынын кыймылсыздандыруучу өнөкөт сезгениши; подагралык артрит), курч подагралык артрит.
- Таяныч-кыймыл аппаратынын дегенеративдүү оорулары (деформациялоочу остеоартроз, остеохондроз).

- Люмбаго, куяң, невралгия, миалгия.
- Муун жактагы ткандардын оорулары (тендовагинит, бурсит).
- Сизгенүү менен коштолгон мертинүүдөн кийинки оору синдромдору, операциядан кийинки оору, баш оору, тиш оору.
- Кулак, тамак, мурундун айкын ооруган жана калтыратма синдрому бар инфекциялык-сезгенген ооруларды комплекстүү дарылоонун курамында (фарингит, тонзиллит, отит).

Каршы көрсөтмө

- диклофенакка, парацетамолго же препараттын кайсы бир көмөкчү кошулмаларына жогорку жеке сезгичтик;
- колко астмасынын приступтары (колко карышуусу), бөрү жатыш, курч ринит же таржымалында диклофенакты, парацетамолду, ацетилсалицил кислотасын же башка стероиддик эмес сезгенүүгө каршы препараттарды колдонууга байланышкан аллергиялардын башка симптомдору;
- ашказандын же ичегинин пептикалык жаралары;
- боор жана/же бөйрөк функцияларынын толукталбаган бузулуулары;
- глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа жетишсиздиги;
- 14 жашка чейинки курактагы балдар;
- Кош бойлуулукта жана бала эмизүү мезгили.

Этияттык менен: ЖИО (жүрөктүн ишемиялык оорусу), ЖӨЖ, цереброваскулярдык оорулар, дислипидемия/гиперлипидемия, кант диабети, четки кан тамырлардын оорулары, ӨБА (КК 30–60 мл/мин), АИЖ жарадан жабыркоолору (таржымалында), *Helicobacter pylori* болушу, боор алсыздыгы, пайда болуучу курч боор порфириясы, залалсыз гипербилирубинемия (анын ичинде Жильбер синдрому), ССКК узак колдонуу, пероралдык ГКС (анын ичинде преднизолонду), антикоагулянттарды (анын ичинде варфаринди), антиагреганттарды (анын ичинде АСК, клопидогрелди), серотонинди кайтарым кармоочу тандалма басаңдаткычтарды (анын ичинде циталопрамды, флуоксетинди, пароксетинди, сертралинди), этанолду, никотинди бир убакта кабыл алуу, улгайган курак.

Кош бойлуу жана бала эмизүү мезгилинде колдонуу:

Препарат кош бойлуу жана бала эмизүү мезгилинде каршы көрсөтүлөт.

Колдонуу жолу жана дозасы

Чоң адамдарга жана 14 жаштан жогору балдарга 1 таблеткадан суткасына 2-3 жолу тамактан кийин же дарыгердин көрсөтмөсү боюнча. Дарылоо узактыгы 5-7 күндөн көп эмес. Дозалар ар бир оорулуу үчүн бейтаптын курагына, оорунун мүнөзүнө жана жүрүшүнө, көтөрүмдүүлүгү жана препараттын дарылоодо натыйжалуулугуна карата жеке аныкталат. Дарылоонун башында чоң адамдарга жана дене салмагы 60 кг.дан ашык өспүрүмдөргө Пардифен препаратын суткасына 2 – 3 таблеткадан дайындоо сунушталат. Оорунун орточо айкындуулук симптомдорунда, ошондой эле узак дарылоодо адатта препараттын 2 таблеткасын суткасына бирден, эртең менен жана кечинде кабыл алуу жетиштүү. Мындай шарттарда Пардифендин суткалык эң жогорку дозасы 3 таблеткадан ашпашы керек. Алгачкы альгодисменореяда препараттын баштапкы дозасы – 1ден 3 чейин таблетка, бирок зарыл учурда сутка ичинде дозаны суткасына 4 таблеткага чейин көбөйтсө болот.

Препаратты колдонуу мөөнөтү 5-7 күндү түзөт жана симптомдордун динамикасына көз каранды.

Чоң адамдар үчүн Пардифен препаратынын эң жогорку суткалык дозасы суткасына 3 таблетканы түзөт.

Кыйыр таасирлери

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: тез-тез - ССКК-гастропатия (эрозиялык-жарадан жабыркоолор), гастралгия, окшуу, кусуу, ич өтүү, ич көбүү, табиттин жоктугу, “боор” трансаминаздарынын активдүүлүгүнүн жогорулашы, ашказан-ичеги кан агуусу (гематемезис, мелена), гепатит (анын ичинде тез өрчүгөн), панкреатит, колит (анын ичинде кан агуу менен оорлошкон), жара колитинин курчушу, Крон оорусунун курчушу, афтоздук стоматит, глоссит, ооз көңдөйүнүн былжырлуу челинин кургашы, эрозиялык эзофагит, ич катуу.

Нерв системасы тарабынан: баш оору, баш айлануу, абдан чарчоо, сезимдин бузулуулары, эске тутуунун төмөндөшү, багытын жоготуу, көрүү курчтугунун азайышы, кош көрүнүү, угуунун төмөндөшү, кулактын чуулдоосу, уйку качуу, кыжырдануу, карышуулар, чүнчүү, тынчсыздануу, "жаман" түш көрүүлөр, титирөө, психоз, даам сезүүнүн бузулушу, сезүүнүн бузулушу, скотома, асептикалык менингит.

Тери катмары тарабынан: жаргак баш, жарыкка сезгичтик, эритематоздуу тери бөртмөсү, ангионевротикалык шишимик, экзема, теринин кычышуусу, былжыр челдеги бөртмө (эритематоздуу, уртикардык).

Заара чыгаруу системасы тарабынан: курч бөйрөк алсыздыгы, гематурия, протеинурия, чарымдуу нефрит, нефротикалык синдром, бөйрөк бүдүрлөрүнүн некрозу, олигурия, цистит, бөйрөк сайгылашуулары, мүнөздүү эмес бактериурия.

Кан жсратуу органдары тарабынан: тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, гемолитикалык аз кандуулук, апластикалык аз кандуулук, метгемоглобинемия, сульфгемоглобинемия, панцитопения, нейтропения.

Аллергиялык реакциялар: колко карышуусу, бөрү жатыш, Стивенс-Джонсон синдрому, Лайелла синдрому, аллергиялык пурпура, системалык анафилактикалык реакциялар (анын ичинде анафилактикалык шок), тери бөртмөсү, ыйлаакчалуу дерматит, эритродермия.

ЖКТС тарабынан: аритмия, АБ жогорулашы, жүрөктүн дүкүлдөшү, көкүрөк клеткасы жактын оорусу.

Башкалар: гипогликемия (анын ичинде гипогликемиялык эстен тануу), импотенция.

Ашыкча доза

Симптомдору: баш айлануу, баш оору, өпкөнү абдан желдетүү, акыл-эстин чаташуусу, тери катмарынын кубаруусу, табиттин жоктугу, окшуу, кусуу, балдарда - миоклониялык карышуулар, окшуу, кусуу, ич оору, “боор” трансаминаздарынын активдүүлүгүнүн жогорулашы, протромбиндик убакыттын жогорулашы (кабыл алгандан 12-48 сааттан кийин кан агуу, боор жана бөйрөк функцияларынын бузулушу, гепатонекроз (парацетамол). Боордун жабыркашынын ачык көрүнүшү 1-6 күндөн кийин билинет. Боор функциясынын бузулушу сейрек өтө тез өрчүйт жана бөйрөк алсыздыгы менен оорлошу мүмкүн (тубулярдык некроз).

Дарылоо: ашказанды жууп тазалоо, активдешкен көмүрдү куюу, артериялык басымдын (АБ) жогорулашын, бөйрөк функциясынын бузулушун, карышуулардын, АИЖ дүүлүгүүлөрүн, дем

алуунун кыйындашынын оору белгилерин жоготууга багытталган дарылоо. Дозасынан ашыргандан 8-9 сааттан кийин SH-тобунун донаторлору жана глутатиондун синтезинин мурункусу - метионин жана 12 сааттан кийин N-ацетилцистеин куюлат. Заараны тездетип ыкчам айдап чыгуу, гемодиализ натыйжасыз. Кошумча дарылоо чараларын жүргүзүү (метионинди андан ары куюу, N-ацетилцистеинди тамыр ичине куюу) зарылдыгы канда парацетамолдун концентрациясына, ошондой эле аны акыркы кабыл алгандан кийин өткөн убактысына карата аныкталат.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Дигоксиндин, циклоспоридин, Li^+ препараттарынын концентрациясын жогорулатат.

Калий үнөмдөөчү диуретиктер менен бир убакта колдонууда гиперкалиемия коркунучун, антикоагулянттар менен – кан агуу коркучун жогорулатат.

Диуретикалык, гипотензивдик жана уйкуну келтирүүчү ДКнын таасирлеринин натыйжалуулугун азайтат.

ССКК, ГКС (ашказан-ичеги кан агуулары) кыйыр таасирлерин, метотрексаттын токсиндүүлүгүн, циклоспориндин нефротоксиндүүлүгүнүн өрчүү коркунучун жогорулатат.

Тромболиттик ДК (алтеплаза, стрептокиназа, урокиназа) менен кабыл алууда кан агуу (көбүнчө АИЖ) коркунучу көбөйөт.

АСК канда диклофенактын концентрациясын азайтат.

Пероралдык гипогликемиялык ДК менен бир убакта колдонууда гипо- же гипергликемия болушу мүмкүн.

Цефамандол, цефоперазон, цефотетан, вальпрой кислотасы, пликамицин менен бир убакта колдонууда гипопротромбинемиянын өрчүү жыштыгы көбөйөт.

Циклоспорин жана алтын препараттары диклофенактын бөйрөктөгү Рg синтезине таасирин күчөтөт, ал нефротоксиндүүлүктүн жогорулашы менен билинет. Парацетамол менен бир убакта колдонуу диклофенактын нефротоксиндүү таасирлеринин өрчүү коркунучун жогорулатат.

Колхицин, кортикотропин, сары чай чөп препараттары, этанол менен бир убакта колдонуу кан агуулар менен коштолгон гастроинтестиналдык кабылдоолордун өрчүү коркунучун көбөйтөт. АКФ басандаткычтарынын, ЖКТБ (жай калций түтүктөрүн бөгөөчүлөр) гипотензивдүү активдүүлүгүн азайтат.

Боордо микросомалдык кычкылдануунун индукторлору (фенитоин, этанол, барбитураттар, рифампицин, фенилбутазон, трициклдик антидепрессанттар) парацетамолдун гепатотоксиндүү таасиринин коркунучун көбөйтөт.

Салицилаттар менен бир убакта узак колдонууда бөйрөктүн, табарсыктын залалдуу ооруларынын өрчүү коркунучун жогорулатат.

Дифлунисал парацетамолдун гепатотоксиндүү таасирин көбөйтүү менен анын плазмалык концентрациясын 50% га жогорулатат.

Барбитураттар менен узак колдонуу парацетамолдун натыйжалуулугун азайтат.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Препаратты колдонуп жаткан убакта, ашказан-ичеги жолунун ооруларына даттанган же таржымалында ашказан же ичегинин жарадан жабыркоолоруна байланыштуу маалыматтары болгон оорулууларга; жара колитинен же Крон оорусунан жабыркаган, боор функциясынын бузулуулары бар бейтаптарга дарыгердин дыкат көзөмөлү зарыл.

Пардифен препаратын колдонуу убагында башка ССККлар сыяктуу эле бир же бир нече боор ферменттеринин активдүүлүгү жогорулашы мүмкүн. Ошондуктан Пардифен препараты менен узак дарыланууда сактык чарасы катары боор функциясын үзгүлтүксүз изилдөө көрсөтүлөт. Эгерде функционалдык көрсөткүчтөрдүн бузулушу күчөсө, же башка кыйыр көрүнүштөр (мисалы, эозинофилия, бөртмөлөр жана башкалар) пайда болсо Пардифенди токтотуу зарыл.

Этияттык ошондой эле боор порфириясынын симптомдору бар оорулууларга Пардифен препаратын колдонууда зарыл, анткени препарат анын приступтарына түрткү бериши мүмкүн. Простагландиндер бөйрөк кан агымын колдоодо маанилүү роль ойнойт, ошондуктан Пардифен препараты менен дарыланууда жүрөк же бөйрөк функциясынын бузулушу бар, улгайган курактагы бейтаптарга, диуретикалык каражаттарды алып жаткан оорулууларга, ошондой эле айланган кандын көлөмү олуттуу азайган адамдарга (мисалы, хирургиялык кийлигишүүлөрдөн кийин) өзгөчө этияттык зарыл.

Мындай учурларда Пардифен препаратын колдонуу убагында сактык чаралары катары бөйрөк функциясын үзгүлтүксүз көзөмөлдөө сунушталат. Препаратты ичүүнү токтотуу адатта бөйрөк функциясынын баштапкы деңгээлине чейин калыбына келишине алып келет.

Препаратты узак колдонууда башка ССККлардай эле четки кан көрүнүшүн системалуу көзөмөлдөө көрсөтүлөт. Пардифен тромбоциттердин агрегациясын убактылуу басышы мүмкүн. Ошондуктан гемостазы бузулган бейтаптарда лабораториялык көрсөткүчтөрдү тыкыр көзөмөлдөө зарыл.

Пардифен препаратын колдонууда улгайган курактагы, өзгөчө алсыз жана дене салмагы аз бейтаптарга этияттык зарыл. Аларга препаратты минималдуу натыйжалуу дозада дайындоо сунушталат.

Автоунаа башкаруу жана механизмдер менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасири

Препаратты колдонуу убагында баш айланууну же көрүүнүн бузулушун сезген бейтаптарга автоунааны айдоо же потенциалдуу коркунучтуу механизмдер менен иштөөгө болбойт.

Чыгаруу формасы

Ар бир алу-ПВХ блистеринде ичүү үчүн 10 таблетка.

10 блистер колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакта.

Сактоо шарты

Кургак, жарык тийбеген жерде 25°C ден жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча.

Төмөнкүлөр үчүн өндүрүлдү /Manufactured for
Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, London, England, SE10 9QF, United Kingdom (Улуу Британия)

Өндүрүүчү /Manufactured by:

Lark Laboratories (India) Ltd.
SP-1192E, Phase-IV, RIICO,
Industrial Area, Bhiwadi,
Dist. Alwar (Rajasthan), India (Индия)

**Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдөн продукциянын (товардын)
сапаты боюнча доо арыздарды кабыл алуучу уюмдун дареги:**

«Аман Фарм» ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,

Тыныстанов көч, 4а үй, 11-бат.

E-mail: [aman.pharm 12@gmail.com](mailto:aman.pharm12@gmail.com)